

PNCT · controle do tabagismo no SUS

O Programa Nacional de Controle do Tabagismo articula prevenção, ambientes livres de fumo e tratamento da dependência na rede. Médico da APS é porta de entrada.

Pilares de política

Lembre - Pilares de política

Preços/impostos, proibição de publicidade, advertências, ambientes fechados livres de fumo e apoio à cessação (MPOWER/OMS como referência conceitual).

Integre abordagem breve, materiais de apoio e farmacoterapia disponível no SUS.

PNCT na pratica

Identificar -> tratar -> seguir

APS identifica

todo contato

Tratamento

grupo / farmaco

Seguimento

recaída comum

Papel do médico

- Registrar tabagismo na história e oferecer tratamento
- Conhecer fluxos locais de grupos de cessação
- Prescrever TSN/bupropiona conforme disponibilidade e CI
- Abordar recaída como parte do processo, sem estigma

Níveis de ação

Nível | Exemplo

Individual | 5As na consulta

Serviço | Grupo de cessação

Intersetorial | Lei antifumo / escolas

Avaliação | Prevalência / metas

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

PNCT não é só 'campanha de cartaz': inclui tratamento clínico da dependência. Recaída " falha moral — reabordar.

Para a prova — escalas e macetes

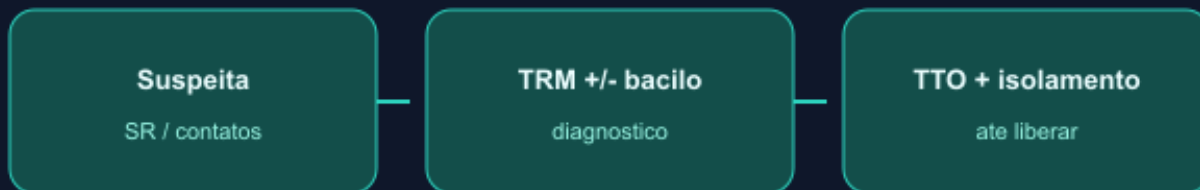
Lembre - Para a prova — escalas e macetes

PNCT: diagnóstico com baciloscopia e/ou TRM-TB, e isolamento respiratório do sintomático/bacilífero até critérios de liberação.

Suspeita clínica !' teste rápido molecular/baciloscopia !' tratamento e controle de infecção.

Fluxo PNCT (ideia)

Suspeita -> TRM/bacilo -> tratar/isolar



Medidas mínimas enquanto houver risco de transmissão.

Controle de infeccao

Isolamento respiratorio

- 1 Isolamento respiratorio do bacilífero / suspeito
- 2 Mascara cirurgica no paciente; N95 na equipe
- 3 Ambiente preferencialmente ventilado / isolamento
- 4 Coleta de escarro com biossegurança

Diagnóstico e isolamento — PNCT

Item | Conduta de prova

TRM-TB | Teste rápido molecular: detecta M. tuberculosis e resistência à rifampicina

Baciloscopia | Esfregação de escarro; útil para carga bacilar e acompanhamento

Cultura | Padrão para confirmação/sensibilidade quando indicada

Isolamento | Suspeito/bacilífero: precauções respiratórias até critérios de liberação

TDO | Tratamento diretamente observado — adesão e cura

Pontos de alto rendimento

- Não atrase tratamento do bacilífero por 'esperar cultura'
- TRM positivo para TB + resistência à R !' fluxo de DR-TB
- Isolamento reduz transmissão nosocomial e domiciliar
- Investigar contatos é parte do programa

Armadilha

Atencao - Armadilha

Baciloscopia negativa não exclui TB (especialmente em crianças e formas extrapulmonares). Integre clínica, imagem e TRM/cultura.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1